TIMECTOMÍA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Gabriela Lorenzo Dorta, Juan José Gutiérrez Adrián, Mª Luisa López Arévalo

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

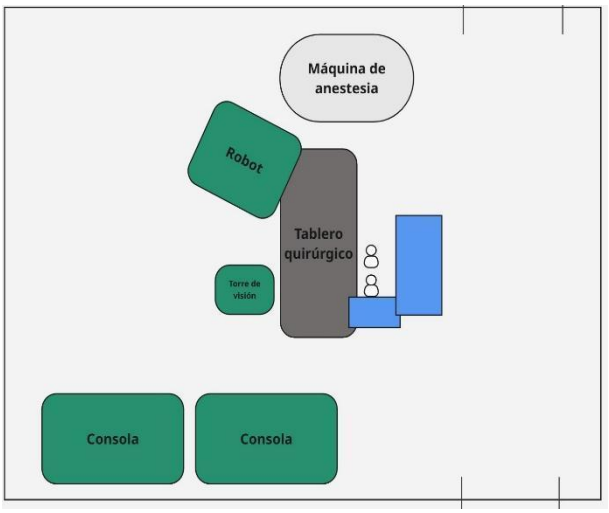
La timectomía es el procedimiento por el que se extirpa, parcial o totalmente, la glándula del timo, localizada en el mediastino anterior, entre el esternón y el corazón. Se realiza principalmente en pacientes con tumores en el timo o casos de miastenia gravis con hiperplasia tímica.

POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE



- Decúbito supino, pegado al borde izquierdo del tablero y un almohadillado bajo tórax izquierdo para elevarlo levemente.
- MSI colocado en un apoyabrazos bajo, para que quede por debajo del eje corporal.
- Brazo derecho alineado con el cuerpo.
- Sujeción a la mesa quirúrgica por debajo de la cresta ilíaca.
- Piernas extendidas, con protección del hueco poplíteo y talones con material acolchado.
- Proteger la cara y el tubo orotraqueal si el brazo del robot tuviese riesgo de golpear la zona. Si se anula el brazo 4 no es necesario.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI



- Anatomía: torácica transversal.
- Lado: derecho.
- Se usan solo 3 brazos:
  - Brazo 1: cadiere.
  - Brazo 2: óptica.
  - Brazo 3: bipolar maryland/ vessel sealer.
  - Brazo 4: no se usa.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

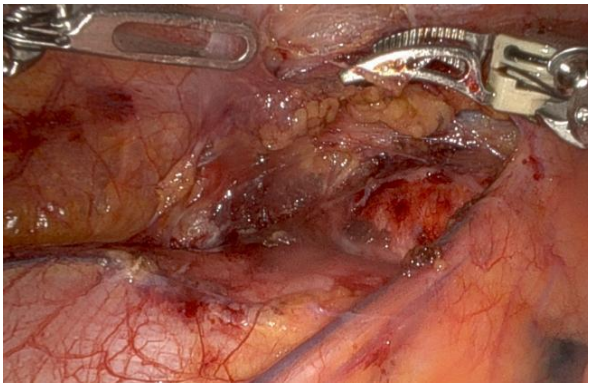
1. Colocación de campo y trócares.
2. El puerto de la cámara se inserta en quinto espacio intercostal sobre la línea axilar anterior.
3. El puerto del brazo 1 en el sexto espacio intercostal inframamario.

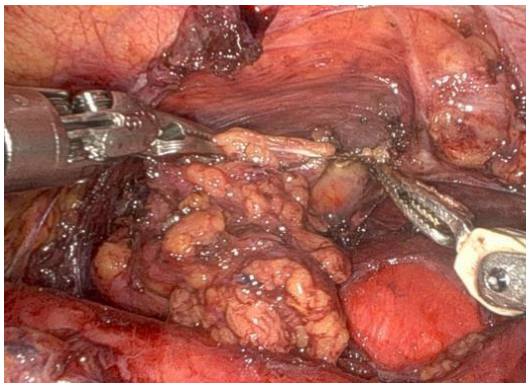


4. El puerto para el brazo 3 se inserta en el tercer espacio sobre la misma línea de la cámara.
5. El puerto accesorio se coloca en octavo espacio intercostal equidistante con los puertos de la cámara y el brazo.
6. Si se usa una óptica de 30º, se puede variar la orientación para conseguir una visión óptima dentro de la cavidad.



7. La disección comienza inferior al ángulo cardiofrénico izquierdo y se extiende a lo largo del borde anterior del nervio frénico.
8. El nervio frénico debe aislarse de todo el tejido mediastínico anterior.





9. Posteriormente, se debe detectar y disecar la asta inferior izquierda del timo sobre el pericardio. Después, se separa la zona retroesternal de la glándula tímica hasta descubrir la asta inferior derecha y la pleura mediastínica derecha.
10. En este punto, se debe elevar la porción inferior del timo, localizar la vena innominada y continuar a lo largo del borde de esta hasta localizar y seccionar las venas tímicas. Para ello se puede utilizar, en función del calibre, la pinza Maryland o el vessel Sealer. La disección debe continuar hacia el cuello hasta detectar y resecar los cuernos superiores.
11. Embolsado de la pieza, control de hemostasia y cierre.



NOTAS

En caso de que existan dificultades para completar el procedimiento mediante cirugía robótica, se optará por VATS o, si se presenta un sangrado no controlable, convertir a esternotomía. Por este motivo, conviene tener el material preparado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Robotic thymectomy: a review of thecniques and results. Coco D., Leanza S. Kardiochirurgia i Thorakochirurgia Polska 2023; 20 (1): 36-44.
2. Robotic Mediastninal Tumor Resections: Position and Port Placement. Okazaki M., Shien K., et. al. J. Pers. Med. 2022, 12, 1195. https://doi.org/10.3390/jpm12081195.